Cirurgia de Emergência no Idoso Frágil

Avaliação, decisão compartilhada e resultados: fragilidade multidimensional, prognóstico centrado em função e valores do paciente

APRESENTAÇÃO	Leticia Nunes Torres (R3 — HSR)
ORIENTAÇÃO	Dra. Ana Rita Passos
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Hospital Santa Helena
DATA E LOCAL	08 de fevereiro de 2027 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Parmar KL et al. Frailty in older patients undergoing emergency laparotomy: the ELF study. Ann Surg. 2021 [1]

Quatro perguntas orientam a aula

1 Como combinar Clinical Frailty Scale, estado funcional, multimorbidade e gravidade fisiológica sem usar idade isoladamente para estimar risco?

Seções 1–3 · resposta na seção 7

2 Quando a laparotomia oferece benefício proporcional aos objetivos do paciente, e como comparar cirurgia, tratamento não operatório e limitação terapêutica?

Seção 4 · resposta na seção 7

3 Como conduzir decisão compartilhada válida em contexto de tempo limitado, incluindo capacidade decisória, representante e possibilidade de dependência funcional?

Seção 5 · resposta na seção 7

4 Quais intervenções perioperatórias modificáveis têm maior plausibilidade para preservar função e reduzir delirium e complicações?

Seção 6 · resposta na seção 7

Ref.: [25]

Um homem de 84 anos chega com abdome agudo: operar, não operar ou confortar?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Homem, 84 anos, mora com a filha
HÁ 2 SEMANAS	Demência leve; bengala; ajuda no banho e nas contas
CHEGADA	3 dias de dor; PA 92/50, FC 118; lactato 4,1; Cr 2,0
TC	Volvo de sigmoide perfurado

Quem decide, com que números e em quanto tempo?

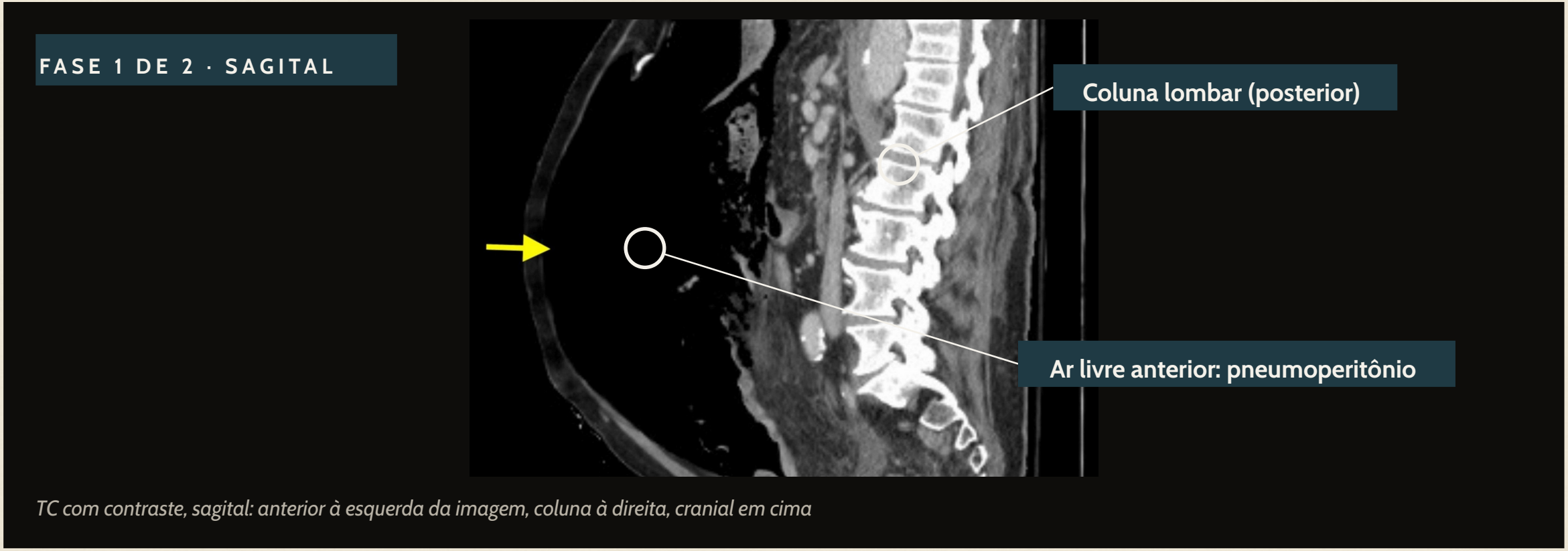
- Caso didático montado com dados das fontes
- Volta em quatro pontos da aula
- Perfuração: diagnóstico mais comum entre os não operados (26%) [14]

MENSAGEM

Idade avançada é o ponto de partida, não a resposta.

Ref.: [5, 14]

O exame que o médico viu: ar livre anterior denuncia a perfuração



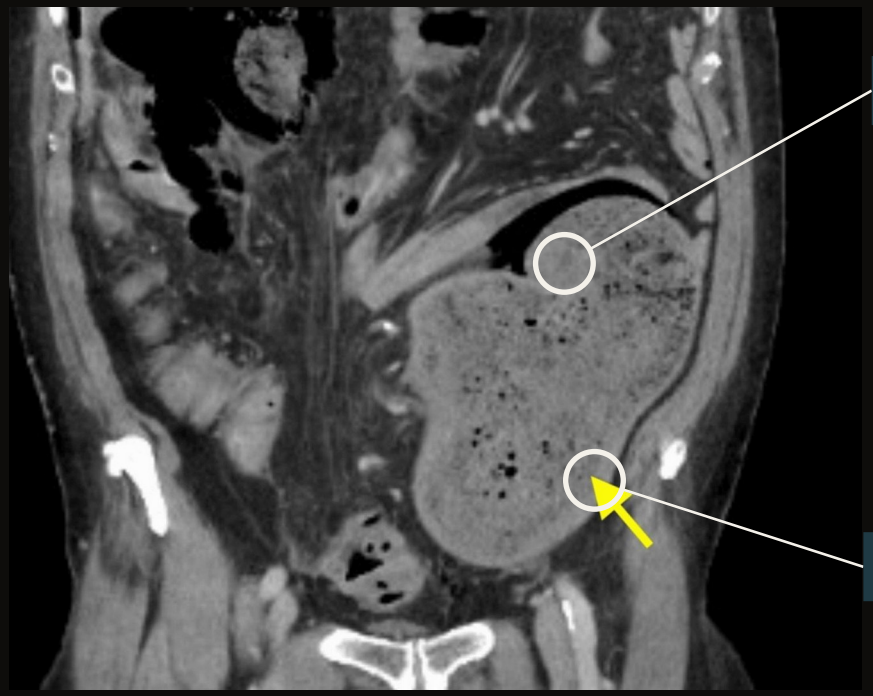
TC com contraste, sagital: anterior à esquerda da imagem, coluna à direita, cranial em cima

Mensagem Exame real publicado (Kim 2026): homem na 9ª década, volvo de sigmoide perfurado.

Fonte: Kim et al., 2026 · Fig. 2 · CC BY 4.0 · PMC13150942 · Ref.: [14]

O cólon dilatado afila no sigmoide: o ponto de torção

FASE 2 DE 2 · CORONAL



TC com contraste, coronal: direita do paciente à esquerda da imagem, cranial em cima

Mensagem A imagem define a doença; a decisão ainda depende de reserva e objetivos.

SUMÁRIO

Sumário

1 Fragilidade: o que é e como medir

2 Prognóstico: morte, função e destino

3 Estratificar sem usar a idade isolada

4 Operar, tratar sem operar ou confortar

5 Decisão compartilhada em tempo limitado

6 Perioperatório que preserva função

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Medir a reserva, prever função, decidir junto e proteger o pós-operatório.

Fragilidade é reserva perdida: a agressão aguda encontra pouca margem

1

Déficits se acumulam

Idade e doenças somam déficits em vários domínios: mobilidade, função, cognição [3, 5].

→

2

A reserva encolhe

Risco maior que o de outras pessoas da mesma idade [5, 25].

→

3

Chega a agressão

Sepse e laparotomia exigem resiliência que o frágil não tem [25, 26].

→

4

O desfecho piora

Morbimortalidade ≥ 2×; delirium > 4×; perda de independência > 5× [3].

Mensagem O prognóstico exige as duas informações: fragilidade basal e gravidade aguda [5].

Ref.: [3, 5, 25, 26]

A fonte: Gottesman 2022 — fragilidade dobra a mortalidade e quintuplica a perda de independência

1. Anaesthesia. 2022 Dec;77(12):1430-1438. doi: 10.1111/anae.15860. Epub 2022 Sep 12.

Frailty and emergency surgery: identification and evidence-based care for vulnerable older adults.

Gottesman D(1), McIsaac DI(2).

When frailty is present before surgery, adjusted rates of morbidity and mortality increase at least two-fold; the odds of delirium and loss of independence are increased more than four- and five-fold, respectively.

TRADUÇÃO Quando a fragilidade está presente antes da cirurgia, a morbidade e a mortalidade ajustadas ao menos dobram; as chances de delirium e de perda da independência aumentam mais de 4 e 5 vezes, respectivamente.

Fonte: Gottesman & McIsaac, Anaesthesia 2022 [3] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

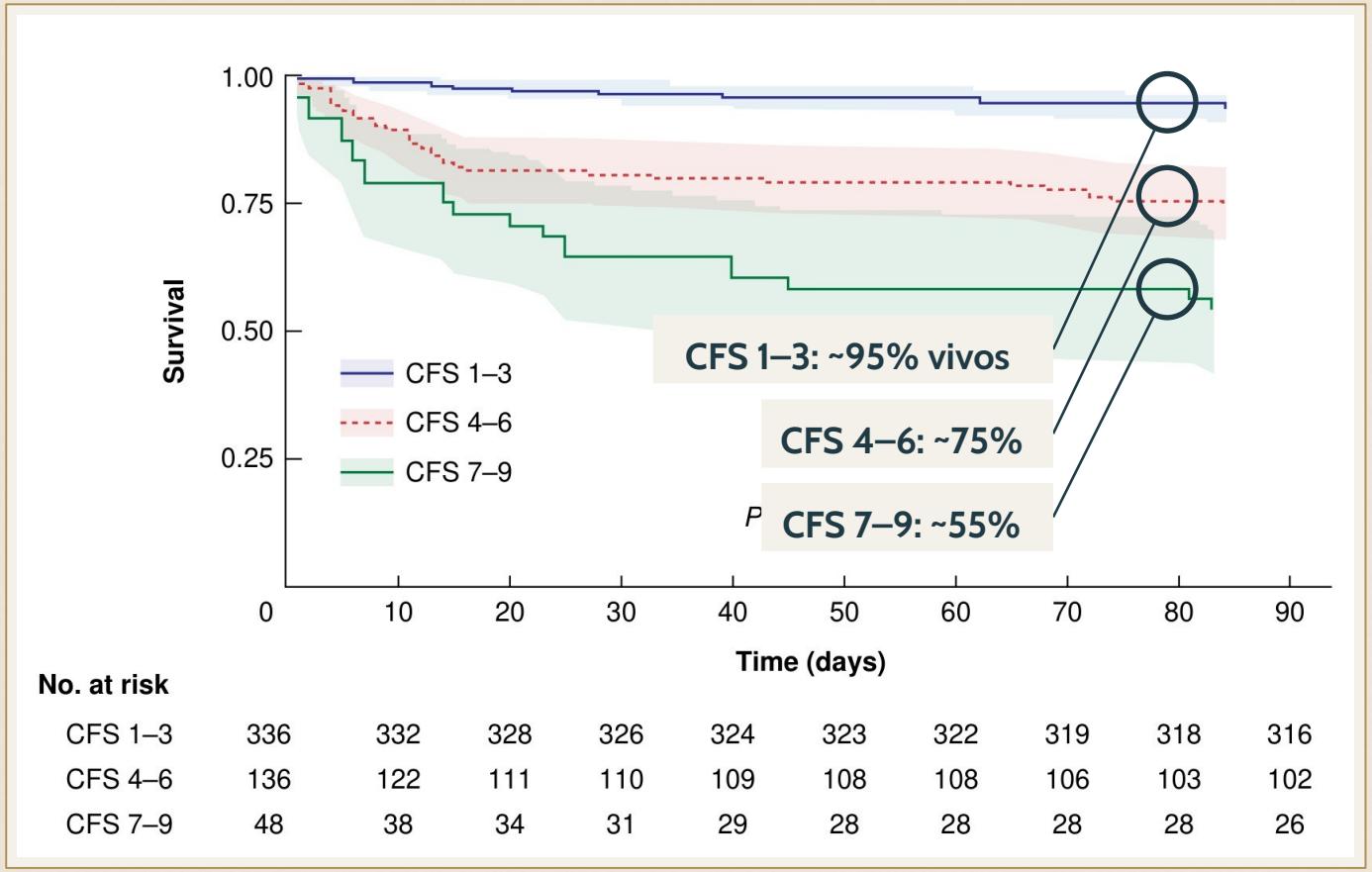
A CFS gradua nove níveis pelo estado de duas semanas antes da doença aguda

CFS	Nome (versão 2.0, 2020)	O que define — resumo próprio em texto
1	Muito em forma	Independente; o nível mais robusto da escala
2	Em forma	Independente; menos robusto que o nível 1
3	Manejando bem	Doença controlada que não limita a atividade
4	Fragilidade muito leve	Lentificado; sintomas mal controlados; tarefas pesadas difíceis
5	Fragilidade leve	Depende de ajuda nas atividades instrumentais (contas, compras)
6	Fragilidade moderada	Dependência também em tarefas intermediárias, sobretudo o banho
7	Fragilidade grave	Dependência progressiva nas atividades básicas; ainda pode andar
8	Fragilidade muito grave	Acamado, aproximando-se do fim da vida
9	Doente terminal	Único nível graduado pelo estado atual, não pelo basal

Pontuar o basal [5]. O ELF usou a versão de 7 pontos (CFS 1–7) e chamou CFS 5–7 de frágil [1].

Ref.: [1, 5, 6]

A sobrevida em 90 dias cai em degraus à medida que a CFS sobe



Coorte dinamarquesa de adultos de todas as idades (n = 520); não é o ELF

- ELF: morte em 90 d — CFS 5 OR 3,18; CFS 6/7 OR 6,10 [1]
- Metanálise: OR 3,84 em 30 d e 3,03 em 1 ano [6]
- Coorte ELLSA: morte em 30 d de 2,1% (CFS 1) a 25,3% (CFS 6–7) [6]
- Excesso de risco segue após 90 d: HR 2,14 na CFS 6 [9]

MENSAGEM

Gradiente dose-resposta, independente da idade [1, 6].

Fonte: Snitkjær et al., 2024 · Fig. 3 · CC BY 4.0 · PMC11126315 · Ref.: [1, 6, 9]

A fonte: ELF — CFS 5 triplica e CFS 6/7 sextuplica a morte em 90 dias

1. Ann Surg. 2021 Apr 1;273(4):709-718. doi: 10.1097/SLA.0000000000003402.

Frailty in Older Patients Undergoing Emergency Laparotomy: Results From the UK Observational Emergency Laparotomy and Frailty (ELF) Study.

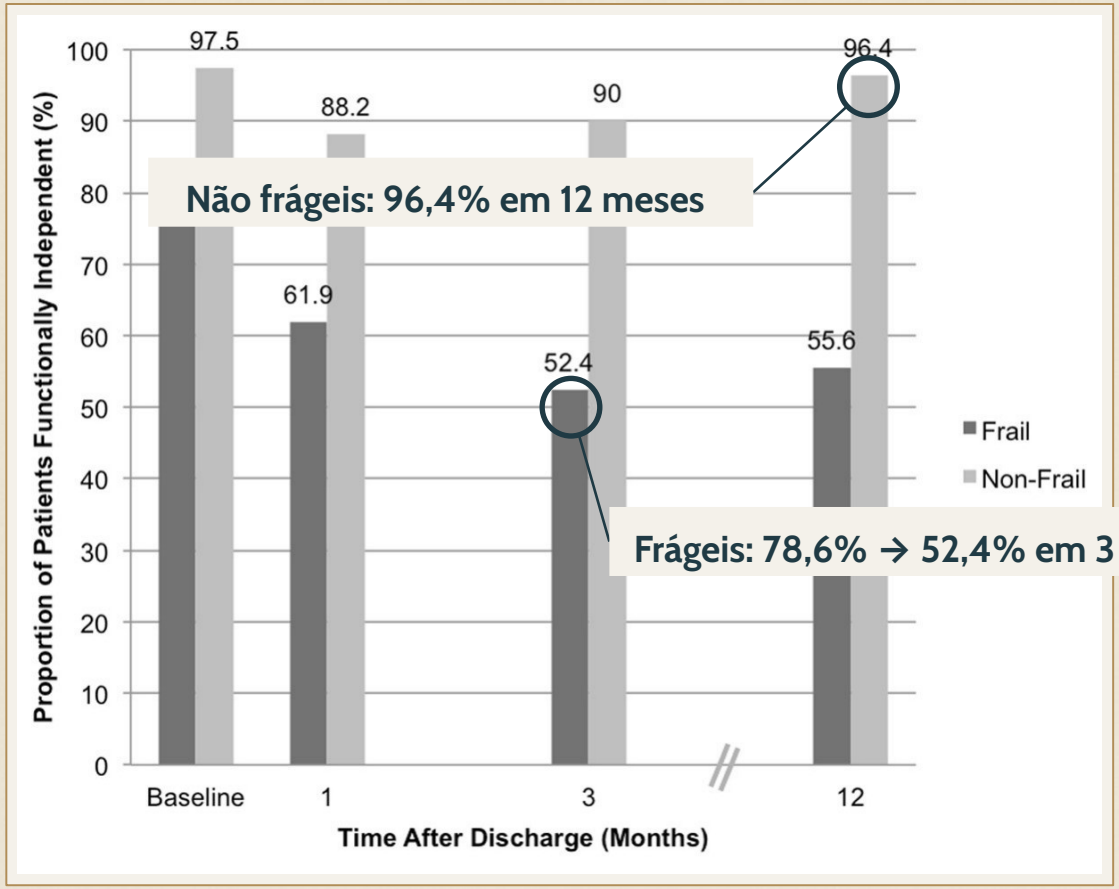
Parmar KL(1), Law J(2), Carter B(3), Hewitt J(4), Boyle JM(5), Casey P(6), Maitra I(7), Farrell IS(8), Pearce L(9), Moug SJ(10); ELF Study Group.

After age and sex adjustment, the risk of 90-day mortality was directly associated with frailty: CFS 5 adjusted odds ratio (aOR) 3.18 [95% confidence interval (CI), 1.24-8.14] and CFS 6/7 aOR 6·10 (95% CI, 2.26-16.45) compared with CFS 1.

TRADUÇÃO Após ajuste para idade e sexo, o risco de morte em 90 dias aumentou diretamente com a fragilidade: CFS 5 OR ajustado 3,18 (IC 95% 1,24–8,14) e CFS 6/7 OR ajustado 6,10 (IC 95% 2,26–16,45) em relação à CFS 1 (ELF: 937 idosos ≥ 65 anos, 49 hospitais do Reino Unido; mortalidade em 90 dias 19,5%; CFS aplicada na versão de 1 a 7).

Fonte: Parmar et al., Ann Surg 2021 (ELF) [1] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

Quem sobrevive frágil muitas vezes não recupera a independência



Singapura, ≥ 65 anos (n = 109); fragilidade pelo mFFC (critérios de Fried), não pela CFS

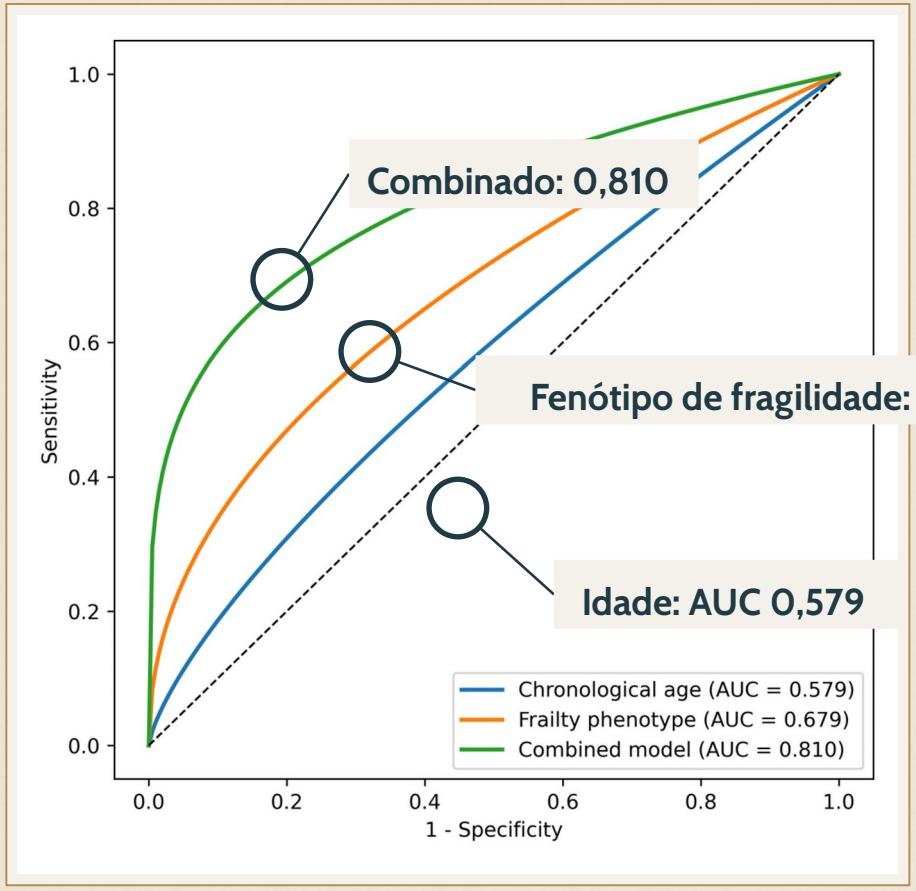
- ELF: 37,4% saíram com mais cuidado que antes [7]
- CFS 6/7: OR 7,88 — e a fragilidade previu melhor que a idade [7]
- 15,9% dos não frágeis ficam frágeis em 90 dias [15]
- ≥ 65 anos: 6,7% × 1,9% vão para instituição [12]

MENSAGEM

Para o idoso, o desfecho é voltar para casa como antes [26].

Fonte: Tan et al., 2019 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC6937965 · Ref.: [7, 12, 15, 26]

A idade sozinha discrimina mal; a fragilidade acrescenta informação



Cirurgia abdominal ELETIVA (n = 223); desfecho: internação prolongada

- EGS-FI: idade sem associação com complicações (OR 0,99) [19]
- Índice de 50 déficits não se correlaciona com a idade [22]
- Com geriatra: CFS previu dependência; idade, nenhum desfecho [24]

MENSAGEM

Idade é marcador grosseiro: na mesma idade, a fragilidade separa [5, 7].

Fonte: Girnyi et al., 2026 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC13258233 · Ref.: [5, 7, 19, 22, 24]

Quatro eixos, quatro instrumentos — e a idade entra só dentro do NELA

Eixo	Instrumento	Número-chave
Fragilidade basal	CFS do estado de 2 semanas antes [5]	CFS 6/7: OR 6,10 para morte em 90 d [1]
Função e cognição	Dependência prévia; 4AT/CAM em todo ≥ 65 anos [25]	CFS 6/7: OR 7,88 para mais cuidado na alta [7]
Multimorbidade	Charlson / ASA [24]	Charlson: HR 1,39 por ponto, morte em 1 ano [24]
Gravidade fisiológica	NELA: idade, PA, FC, bioquímica, ASA [17]	Estatística C 0,86; UTI se risco ≥ 5% [17, 27]

Divergência: somar a CFS ao NELA elevou a AUC de 0,814 para 0,864 num estudo e não mudou na coorte ELLSA [6].

Mensagem Regra prática: NELA + CFS + função/cognição; paciente frágil = alto risco [6].

Ref.: [1, 5, 6, 7, 17, 24, 25, 27]

De volta ao caso: no PS ele parece CFS 7, mas o basal é CFS 6

CASO DIDÁTICO · RETORNO

CFS	Basal: bengala e ajuda no banho → CFS 6, não 7
RISCO	CFS 6/7: OR 6,10 [1]; NELA ≥ 5%
COGNIÇÃO	4AT positivo: delirium + demência
VALORES	Sem DAV; a filha conhece os valores

Alto risco confirmado. Ele consegue decidir?

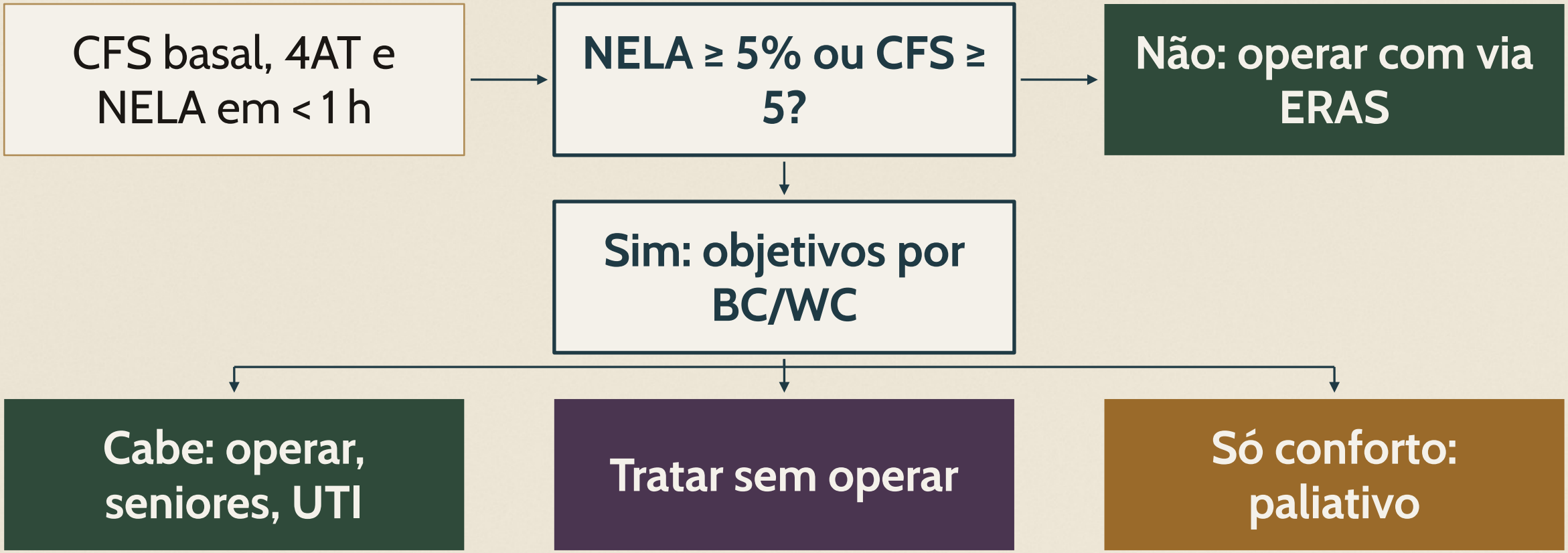
- Pontuar pelo agudo superestima a fragilidade [5]
- Frágil = alto risco; UTI se NELA ≥ 5% [6, 27]
- Delirium muda a avaliação de capacidade [25]

MENSAGEM

Risco medido em quatro eixos, e nenhum deles é a idade.

Ref.: [1, 5, 6, 25, 27]

A máquina de decisão: risco medido, objetivos conhecidos, então a via



Mensagem A idade não é um nó: entra só dentro do NELA [17, 25].

Ref.: [5, 17, 25, 26, 27, 28]

O caminho errado: decidir pela idade — ou operar sem conversar sobre objetivos

CAMINHO ERRADO

"84 anos: idade proibitiva, não opera." Ou o inverso: "abdome agudo, laparotomia já", sem conversa de objetivos.

O QUE ACONTECE

- Com fragilidade medida, a idade perde poder (OR 0,99) [19, 22]
- 21% dos não operados vivem; 77% deles em casa [14]
- 18,3% dos idosos falecidos operados no último mês de vida [33]
- 37,4% saem com mais cuidado: precisa entrar na conversa [7, 32]

POR QUE ERRA

A via nasce do risco medido e dos objetivos; a idade só entra dentro do escore [17, 25].

Mensagem Nem a idade veta, nem o abdome agudo obriga.

Ref.: [7, 14, 19, 22, 25, 32, 33]

Sumário — onde estamos

1 Fragilidade: o que é e como medir — CONCLUÍDA

2 Prognóstico: morte, função e destino — CONCLUÍDA

3 Estratificar sem usar a idade isolada — CONCLUÍDA

4 Operar, tratar sem operar ou confortar

5 Decisão compartilhada em tempo limitado

6 Perioperatório que preserva função

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Segunda metade: comparar opções, decidir junto e proteger o pós-operatório.

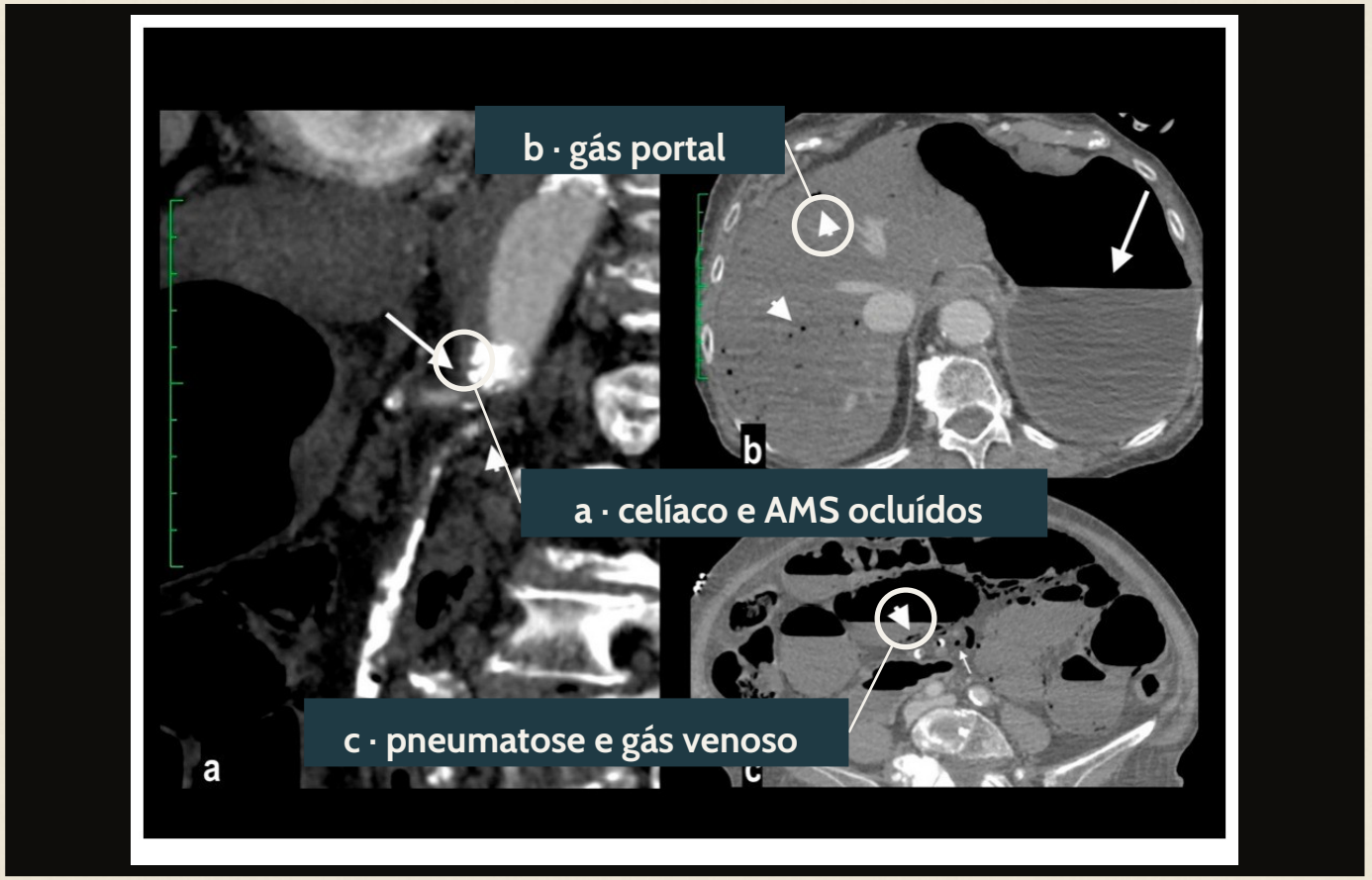
Comparar trajetórias de cada opção, não só a sobrevida de 30 dias

Opção	Morte	Função e destino
Laparotomia, ≥ 65 anos	15,3% em 30 d · 20,4% em 90 d [12]	6,7% vão para instituição (× 1,9%) [12]
Laparotomia, ≥ 80 anos	17% em 30 d · 22% em 90 d (NELA, via ERAS) [25]	Muitos não voltam à independência prévia [26]
Laparotomia, frágil	39,1% em 1 ano [8]	CFS 6/7: OR 7,88 para mais cuidado (ELF) [7]
Não operar (NoLap)	79% em 90 d [14]	21% vivos; 77% destes em casa, com mais cuidado [14]
Só conforto (paliativo)	Objetivo: controle de sintomas [27]	Não é o mesmo que tratamento ativo sem cirurgia [27]

Mensagem Benefício proporcional: o melhor e o mais provável cabem nos objetivos [25, 28].

Ref.: [7, 8, 12, 14, 25, 26, 27, 28]

Quando a fisiologia já colapsou, operar pode não trazer benefício proporcional



Mulher de 78 anos, isquemia mesentérica maciça; óbito em horas, sem cirurgia descrita

- Risco muito alto: discutir limites de cuidado antes de operar [25]
- Decidir com cirurgião, anestesista e intensivista seniores [27]
- Reavaliar o risco ao fim da cirurgia [27]
- Mas úlcera perfurada com escore alto pode valer uma operação curta [25]

MENSAGEM

O escore estima; a decisão pesa operação, reserva e objetivos [25].

Fonte: Ronza et al., 2024 · Fig. 4 · CC BY 4.0 · PMC11202795 · Ref.: [25, 27]

Sem capacidade, valem as diretivas antecipadas — inclusive sobre a família

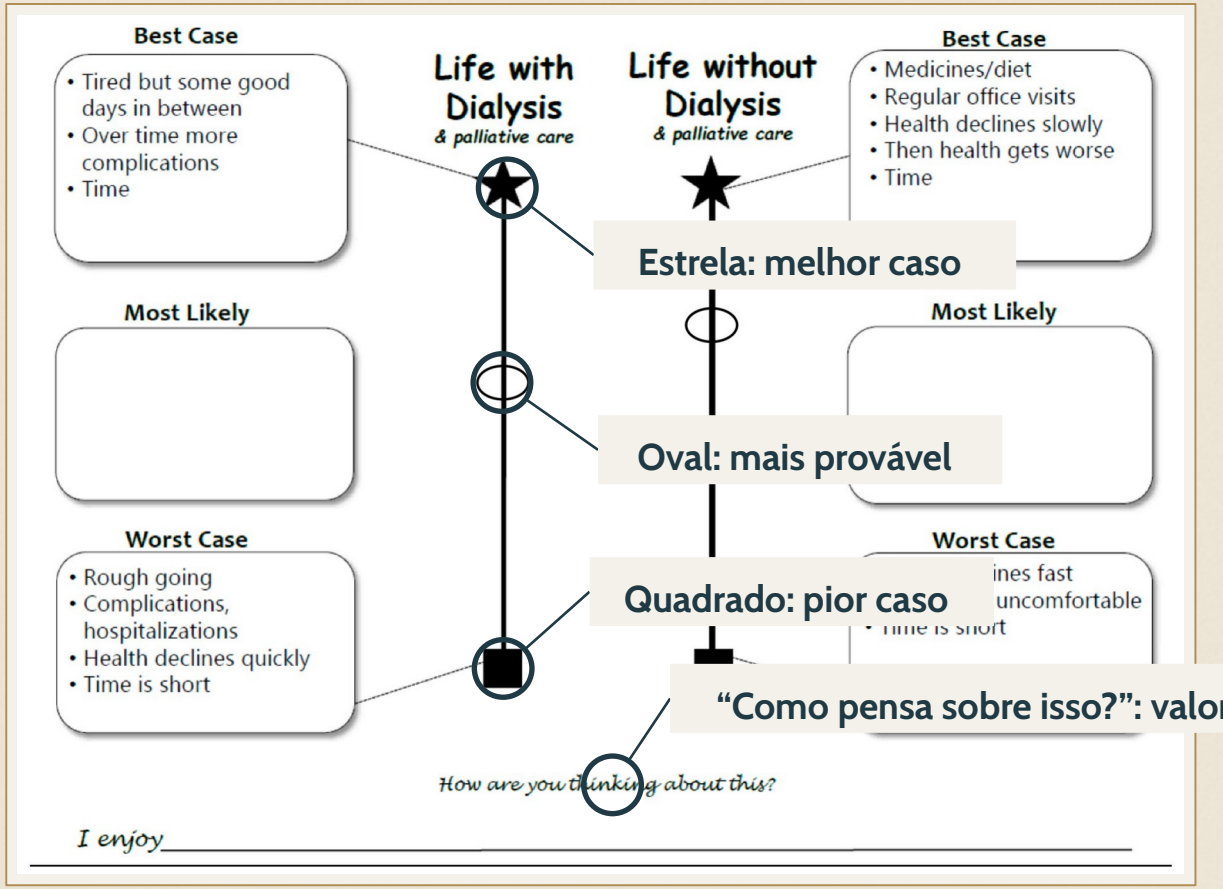
Situação	Conduta	Base
O paciente decide?	Capacidade para esta decisão: comunicar, compreender, apreciar, raciocinar	Clássico [34]
Delirium no PS	Rastrear antes (4AT/CAM): muda a avaliação de capacidade	ERAS [25]
Incapaz, com diretiva antecipada	Seguir a DAV; prevalece até sobre o desejo da família	Res. CFM 1.995/2012 [46]
Representante designado	As informações dele também são levadas em conta	Res. CFM 1.995/2012 [46]
Sem DAV, representante ou consenso	Comitê de Bioética, Comissão de Ética Médica ou CRM/CFM	Res. CFM 1.995/2012 [46]

Res. CFM 1.995/2012 lida em transcrição (Normas Legais) — conferir no portal do CFM antes de projetar.

Mensagem Registrar no prontuário: DAV, representante e a conversa [46].

Ref.: [25, 34, 46]

Best Case/Worst Case: uma barra por opção, com melhor, pior e mais provável



Versão de nefrologia (diálise × conservador): mesma estrutura do BC/WC cirúrgico

- Nomear as opções: operar × não operar [28]
- Narrar cada cenário como história de vida, não lista de complicações [28]
- Desenhar à mão e deixar o papel com a família [28]
- Críticas: baixa escolaridade e viés de quem desenha [28]

MENSAGEM

Treino de 2 h: OPTION5 de 41 para 74 [29].

Fonte: Haug et al., 2022 · Fig. 1 · CC BY-NC 4.0 · PMC9639110 · Ref.: [28, 29]

O BC/WC do caso, construído com a filha como voz dos valores dele

A · Hartmann — melhor: em casa em ~2 semanas, com colostomia e mais ajuda	B · Tratar sem operar — melhor: entre os 21% vivos, em casa [14]	C · Só conforto — melhor: sem dor, com a família, como ele dizia querer
Mais provável: sobrevive, com mais dependência (OR 7,88 na CFS 6/7) [7]	Mais provável: morte em semanas (79% em 90 dias) [14]	Mais provável: morte em dias, com sintomas controlados
Pior: dias de ventilação e morte na UTI	Pior: morte em poucos dias, no hospital [14]	Pior: desconforto se os sintomas não forem antecipados

Mensagem Exemplo didático. A escolha segue os valores dele; discutir UTI, intubação e reanimação [25].

Ref.: [7, 14, 25, 27, 28]

A fonte: Taylor 2017 — treino em BC/WC elevou a decisão compartilhada de 41 para 74

▸ JAMA Surg. 2017 Jun 21;152(6):531–538. doi: 10.1001/jamasurg.2016.5674

A Framework to Improve Surgeon Communication in High-Stakes Surgical Decisions

Best Case/Worst Case

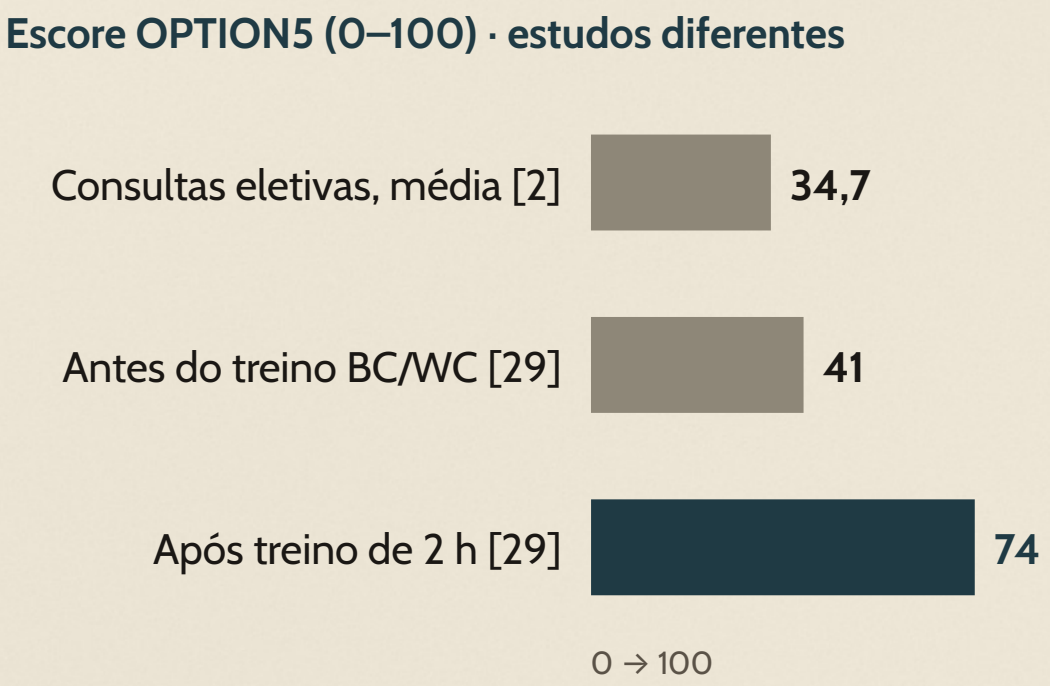
Lauren J Taylor [1], Michael J Nabozny [1], Nicole M Steffens [2], Jennifer L Tucholka [1], Karen J Brasel [3], Sara K Johnson [4], Amy Zelenski [4], Paul J Rathouz [5], Qianqian Zhao [5], Kristine L Kwekkeboom [6], Toby C Campbell [4], Margaret L Schwarze [1,7,✉]

The median OPTION 5 score improved from 41 preintervention (interquartile range, 26- 66) to 74 after Best Case/Worst Case training (interquartile range, 60-81).

TRADUÇÃO O escore OPTION 5 mediano de decisão compartilhada subiu de 41 (IIQ 26–66) antes para 74 (IIQ 60–81) após o treinamento em Best Case/Worst Case (estudo pré-pós, 32 pacientes de 68–95 anos com problema cirúrgico agudo não emergente, 1 centro).

Fonte: Taylor et al., JAMA Surg 2017 (Best Case/Worst Case) [29] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

Decisão compartilhada boa cabe em menos de 30 min — num estudo de ambulatório eletivo



- Variação por cirurgião: mediana de 10 a 65 [2]
- Mais decisão compartilhada quando o cirurgião reluta (+7,4) [2]
- 57% das conversas boas duraram ≤ 26 min [2]
- Lista de perguntas ao paciente não mudou o escore [2, 30]

Baggett: consultas ambulatoriais ELETIVAS (≥ 60 anos); Taylor: pré-pós sem controle.

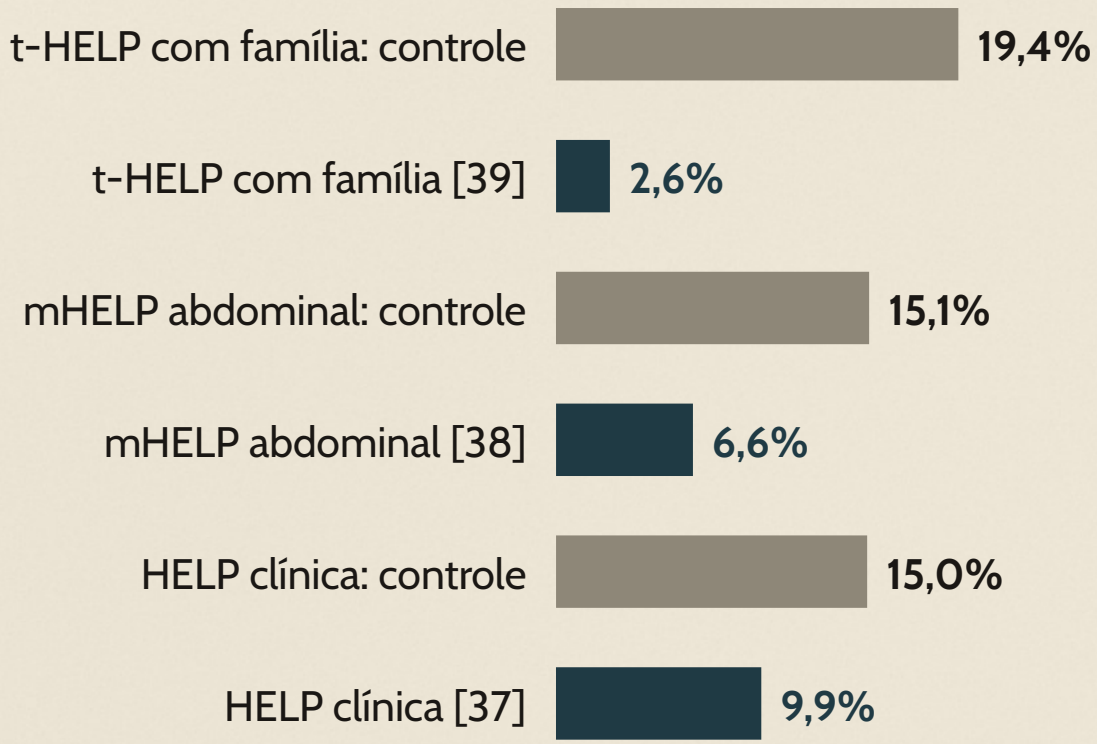
MENSAGEM

Na emergência, a estrutura encurta a conversa [25, 28].

Ref.: [2, 25, 28, 29, 30]

Prevenção de delirium tipo HELP reduz o delirium à metade ou mais

Delirium (%): controle × intervenção, em ECR



ECRs em clínica e cirurgia eletiva; na urgência, extrapolação (ERAS) [26].

- Metanálise HELP: delirium OR 0,47 [36]
- Rastrear com 4AT/CAM 2×/dia até o 5º dia [26]
- Evitar Beers: benzodiazepínico e anticolinérgico [26]
- Cirurgia abdominal ≥ 65 anos: delirium em 30% [43]

MENSAGEM

Delirium é evitável em cerca de 40% com medidas simples [26].

Ref.: [26, 36, 37, 38, 39, 43]

Cinco alavancas modificáveis, em ordem de plausibilidade

Intervenção	O que fazer	Evidência
Prevenção de delirium (HELP)	Orientação, sono, mobilidade, óculos, aparelho auditivo, hidratação; com a família	Metanálise OR 0,47; ECR: NNT 5,9 [36, 39]
Geriatria colaborativa	Co-manejo desde a admissão; práticas amigas do idoso	Observacional: OR 0,38 em 30 d [12]; EASE [35]
Analgesia poupadora de opioide	Paracetamol regular, AINE se possível, bloqueios; sem gabapentinoide	Diretriz ERAS [26]
Nutrição precoce	Via oral cedo; enteral em 24 h se ingestão < 50% por > 7 d	ECR + diretrizes [26, 41]
Mobilização precoce	Sentar e andar o mais cedo possível	Recomendação forte, evidência fraca [26]

Mensagem Mais plausível: HELP (ECRs) > geriatria (observacional) > mobilização (extrapolada).

Ref.: [12, 26, 35, 36, 39, 41]

Desfecho do caso: operado com limites combinados e alta com cuidado redesenhado

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

DECISÃO	Hartmann, limites combinados, reavaliar em 48 h
SALA	Seniores e UTI [27]
PÓS-OP	Geriatra no D1; HELP com a filha; 4AT [26, 39]
ALTA	Reavaliar CFS e DAV na alta [3, 15]

E se a filha escolhesse não operar? Também seria boa decisão.

- Primeiras 48 h informam: melhora da mobilidade prevê boa evolução [5]
- 1 em 6 não frágeis fica frágil em 90 dias [15]
- Excesso de risco persiste: HR 2,14 na CFS 6 [9]

MENSAGEM

Boa decisão = alinhada aos objetivos, opere ou não.

Ref.: [3, 5, 9, 15, 25, 26, 27, 39]

Pergunta 1: quatro eixos, e a idade só dentro do escore

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como combinar Clinical Frailty Scale, estado funcional, multimorbidade e gravidade fisiológica sem usar idade isoladamente para estimar risco?

- Fragilidade: CFS basal — CFS 6/7 OR 6,10 em 90 d [1, 5]
- Função e cognição: OR 7,88 para mais cuidado; 4AT em todo ≥ 65 [7, 25]
- Multimorbidade (Charlson HR 1,39) e fisiologia (NELA, C 0,86) [17, 24]
- Idade isolada falha: OR 0,99 no EGS-FI [19]

VEREDITO

NELA + CFS basal + função/cognição; frágil = alto risco; UTI se NELA ≥ 5%.

Ref.: [1, 5, 7, 17, 19, 24, 25]

Pergunta 2: há benefício proporcional quando o melhor e o mais provável cabem nos objetivos

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quando a laparotomia oferece benefício proporcional aos objetivos do paciente, e como comparar cirurgia, tratamento não operatório e limitação terapêutica?

- Operar, ≥ 65 anos: 20,4% de morte em 90 d [12]; 37,4% saem com mais cuidado [7]
- Não operar: 79% morrem em 90 d; 21% vivem, quase todos em casa [14]
- Paliativo ≠ tratamento ativo sem cirurgia [27]
- Operação curta pode valer mesmo com escore alto [25]

VEREDITO

Comparar trajetórias de cada opção e documentar alternativas e objetivos de cuidado.

Ref.: [7, 12, 14, 25, 27, 28]

Pergunta 3: capacidade, representante e uma estrutura que cabe em minutos

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como conduzir decisão compartilhada válida em contexto de tempo limitado, incluindo capacidade decisória, representante e possibilidade de dependência funcional?

- Capacidade para esta decisão; rastrear delirium antes [25, 34]
- Incapaz: DAV prevalece sobre a família; sem consenso → bioética/CRM [46]
- BC/WC com a dependência na conversa; treino: 41 → 74 [28, 29]
- Ressalva: "< 30 min" vem do ambulatório eletivo [2]

VEREDITO

Estrutura + valores + registro: decisão válida em minutos, com o paciente ou com quem fala por ele.

Ref.: [2, 25, 28, 29, 34, 46]

Pergunta 4: HELP e geriatria lideram; analgesia, nutrição e mobilização completam

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quais intervenções perioperatórias modificáveis têm maior plausibilidade para preservar função e reduzir delirium e complicações?

- HELP: OR 0,47; com família 2,6% × 19,4% (NNT 5,9) [36, 39]
- Geriatria: OR 0,38 (observacional); EASE 33,3% → 13,6% [12, 35]
- Sem Beers nem gabapentinoide; paracetamol + bloqueio [26]
- Dieta e mobilização precoces [26, 41]

VEREDITO

Mais plausível: HELP com a família + co-manejo geriátrico desde a admissão.

Ref.: [12, 26, 35, 36, 39, 41]

Forja 1 — o paciente que parece frágil no PS

Homem de 79 anos, ativo, vive sozinho, sem dependências até 10 dias atrás; hoje, prostrado no PS por obstrução, vai para laparotomia. Para graduar a CFS, o correto é:

A Graduar pelo estado atual no pronto-socorro, que reflete a reserva real

B Considerar a idade acima de 75 anos equivalente a fragilidade

C Adiar a avaliação para o pós-operatório, com o paciente estável

D Graduar pelo estado basal das 2 semanas anteriores à doença aguda

E Aplicar um índice que exige teste de marcha e força de preensão

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 1 — o paciente que parece frágil no PS

Homem de 79 anos, ativo, vive sozinho, **sem dependências até 10 dias atrás**; hoje, prostrado no PS por obstrução, vai para laparotomia. Para graduar a CFS, o correto é:

A. Graduar pelo estado atual no pronto-socorro, que reflete a reserva real

B. Considerar a idade acima de 75 anos equivalente a fragilidade

C. Adiar a avaliação para o pós-operatório, com o paciente estável

D. Graduar pelo estado basal das 2 semanas anteriores à doença aguda

E. Aplicar um índice que exige teste de marcha e força de preensão

GABARITO D · COMENTÁRIO

A CFS gradua o basal de 2 semanas antes (≈ CFS 2–3); só a CFS 9 usa o estado atual [5]. Idade não prevê risco com fragilidade medida [19]; marcha e preensão são inviáveis no agudo [6].

Forja 2 — a diretiva e os filhos

Mulher de 86 anos, CFS 7, perfuração colônica, sem capacidade por delirium; diretiva antecipada escrita recusa cirurgia e UTI; os filhos exigem “fazer tudo”. Pela Res. CFM 1.995/2012:

A Respeitar a diretiva, registrar e oferecer tratamento sem cirurgia ou conforto

B Operar, porque a vontade dos filhos como família prevalece

C Aguardar a resolução do delirium para que a própria paciente decida

D Encaminhar ao Comitê de Bioética antes de qualquer conduta

E Decidir pelo risco previsto no escore NELA

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 2 — a diretiva e os filhos

Mulher de 86 anos, CFS 7, perfuração colônica, sem capacidade por delirium; **diretiva antecipada escrita** recusa cirurgia e UTI; os filhos exigem "fazer tudo". Pela Res. CFM 1.995/2012:

A **Respeitar a diretiva, registrar e oferecer tratamento sem cirurgia ou conforto**

B Operar, porque a vontade dos filhos como família prevalece

C Aguardar a resolução do delirium para que a própria paciente decida

D Encaminhar ao Comitê de Bioética antes de qualquer conduta

E Decidir pelo risco previsto no escore NELA

GABARITO A · COMENTÁRIO

A DAV prevalece sobre pareceres não médicos, inclusive a família; registrar no prontuário. Comitê só sem DAV, representante ou consenso [46]; escore não substitui valores [25].

Forja 3 — prevenir o delirium

Homem de 81 anos operado de emergência (colectomia), com déficit auditivo e demência leve. Qual conjunto tem a melhor evidência para reduzir delirium pós-operatório?

A. Benzodiazepínico noturno para preservar o sono

B. Gabapentina associada ao esquema analgésico

C. Programa multicomponente tipo HELP, com a família, e rastreio diário com 4AT/CAM

D. Analgesia com PCA de morfina como base do esquema

E. Jejum oral até o retorno do trânsito intestinal

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 3 — prevenir o delirium

Homem de 81 anos operado de emergência (colectomia), com déficit auditivo e demência leve. Qual conjunto tem a **melhor evidência para reduzir delirium** pós-operatório?

A. Benzodiazepínico noturno para preservar o sono

B. Gabapentina associada ao esquema analgésico

C. Programa multicomponente tipo HELP, com a família, e rastreio diário com 4AT/CAM

D. Analgesia com PCA de morfina como base do esquema

E. Jejum oral até o retorno do trânsito intestinal

GABARITO C · COMENTÁRIO

HELP: OR 0,47; 6,6% × 15,1% em cirurgia abdominal; 2,6% × 19,4% com família [36, 38, 39]. Benzodiazepínico e gabapentinoide são danosos; dieta precoce é segura [26].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

Idoso candidato a laparotomia

CFS basal + 4AT + NELA [5, 25]

Séptico no PS, "em forma" antes

Graduar a CFS pelo basal [5]

CFS ≥ 5

Alto risco; falar de dependência [1, 7]

Decisão só pela idade

Trocar por fragilidade + fisiologia [19, 22]

NELA ≥ 5%

UTI no pós-operatório; seniores [27]

Risco muito alto

Limites de cuidado antes de operar [25, 27]

Capaz, decisão difícil

BC/WC: melhor, pior, mais provável [28]

Incapaz, com DAV

DAV prevalece sobre a família [46]

Sem DAV nem consenso

Comitê de Bioética, CEM ou CRM [46]

Decisão de não operar

Paliativo ≠ ativo sem cirurgia; documentar [27]

Pós-operatório ≥ 65 anos

Geriatra + HELP + 4AT até D5 [26]

Benzodiazepínico, gabapentinoide

Evitar no idoso (Beers) [26]

Ref.: [1, 5, 7, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 46]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Fragilidade:** é reserva perdida, medida pela CFS do basal de 2 semanas antes, não pela idade [5, 25].
2. **Prognóstico:** CFS 6/7 sextuplica a morte em 90 dias, e muitos sobreviventes perdem independência [1, 7].
3. **Risco:** NELA + CFS + função/cognição definem o risco; os objetivos definem a via [17, 25].
4. **Conversa:** BC/WC e diretivas antecipadas tornam a decisão válida mesmo com pouco tempo [28, 46].
5. **Perioperatório:** HELP com a família e geriatra desde a admissão protegem cognição e função [26, 39].

Mensagem Operar, não operar ou confortar: todas podem ser boas decisões, se alinhadas aos objetivos.

Ref.: [1, 5, 7, 17, 25, 26, 28, 39, 46]

Referências citadas (32)

1. Parmar KL, et al. Frailty in older patients undergoing emergency laparotomy: results from the UK Observational Emergency Laparotomy and Frailty (ELF) study. Ann Surg. 2021;273(4):709-18.

2. Baggett ND, et al. Surgeon use of shared decision-making for older adults considering major surgery: a secondary analysis of a randomized clinical trial. JAMA Surg. 2022;157(5):406-13.

3. Gottesman D, McIsaac DI. Frailty and emergency surgery: identification and evidence-based care for vulnerable older adults. Anaesthesia. 2022;77(12):1430-8.

5. Rockwood K, Theou O. Using the Clinical Frailty Scale in allocating scarce health care resources. Can Geriatr J. 2020;23(3):210-5.

6. Park B, et al. Frailty using the Clinical Frailty Scale to predict short- and long-term adverse outcomes following emergency laparotomy: meta-analysis. BJS Open. 2024;8(4):zrae078.

7. Carter B, et al. Association between preadmission frailty and care level at discharge in older adults undergoing emergency laparotomy. Br J Surg. 2020;107(3):218-26.

8. Park B, et al. Association between frailty, long-term mortality and functional outcomes for older adults undergoing emergency laparotomy. World J Surg. 2024;48(5):1111-22.

9. Price A, et al. Estimating the effect of frailty on longer-term survival following emergency laparotomy: an observational study using National Emergency Laparotomy Audit data. Anaesthesia. 2025;80(9):1083-92.

12. Aitken RM, et al. Older patients undergoing emergency laparotomy: observations from the National Emergency Laparotomy Audit (NELA) years 1-4. Age Ageing. 2020;49(4):656-63.

14. Price A, et al. Characterisation of older patients that require, but do not undergo, emergency laparotomy: a multicentre cohort study. Br J Anaesth. 2024;133(5):973-82.

15. Ng HJ, Rattray NJW, Quasim T, Moug SJ. Changes in frailty status and discharge destination post emergency laparotomy. World J Emerg Surg. 2025;20(1):37.

17. Eugene N, et al. Development and validation of a prognostic model for death 30 days after adult emergency laparotomy. Anaesthesia. 2023;78(10):1262-71.

19. Orouji Jokar T, et al. Emergency general surgery specific frailty index: a validation study. J Trauma Acute Care Surg. 2016;81(2):254-60.

22. Joseph B, et al. Emergency general surgery in the elderly: too old or too frail? J Am Coll Surg. 2016;222(5):805-13.

24. Teh R, Teo S, Trivedi A, Kumarasinghe AP. Emergency laparotomy in older adults with geriatric medicine input: implications of demographics, frailty and comorbidities on outcomes. ANZ J Surg. 2024;94(7-8):1365-72.

25. Peden CJ, et al. Guidelines for perioperative care for emergency laparotomy Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations: part 1 — preoperative: diagnosis, rapid assessment and optimization. World J Surg. 2021;45(5):1272-90.

26. Scott MJ, et al. Consensus guidelines for perioperative care for emergency laparotomy Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations part 2 — emergency laparotomy: intra- and postoperative care. World J Surg. 2023;47(8):1850-80.

27. Peden CJ, et al. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society consensus guidelines for emergency laparotomy part 3: organizational aspects and general considerations for management of the emergency laparotomy patient. World J Surg. 2023;47(8):1881-98.

28. Kruser JM, et al. "Best Case/Worst Case": qualitative evaluation of a novel communication tool for difficult in-the-moment surgical decisions. J Am Geriatr Soc. 2015;63(9):1805-11.

29. Taylor LJ, et al. A framework to improve surgeon communication in high-stakes surgical decisions: Best Case/Worst Case. JAMA Surg. 2017;152(6):531-8.

30. Schwarze ML, et al. Effectiveness of a question prompt list intervention for older patients considering major surgery: a multisite randomized clinical trial. JAMA Surg. 2020;155(1):6-13.

32. Cooper Z, Courtwright A, Karlage A, Gawande A, Block S. Pitfalls in communication that lead to nonbeneficial emergency surgery in elderly patients with serious illness: description of the problem and elements of a solution. Ann Surg. 2014;260(6):949-57.

33. Kwok AC, et al. The intensity and variation of surgical care at the end of life: a retrospective cohort study. Lancet. 2011;378(9800):1408-13.

34. Appelbaum PS. Clinical practice. Assessment of patients' competence to consent to treatment. N Engl J Med. 2007;357(18):1834-40.

35. Khadaroo RG, et al. Clinical effectiveness of the Elder-Friendly Approaches to the Surgical Environment initiative in emergency general surgery. JAMA Surg. 2020;155(4):e196021.

36. Hshieh TT, Yang T, Gartaganis SL, Yue J, Inouye SK. Hospital Elder Life Program: systematic review and meta-analysis of effectiveness. Am J Geriatr Psychiatry. 2018;26(10):1015-33.

37. Inouye SK, et al. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. N Engl J Med. 1999;340(9):669-76.

38. Chen CC, et al. Effect of a modified Hospital Elder Life Program on delirium and length of hospital stay in patients undergoing abdominal surgery: a cluster randomized clinical trial. JAMA Surg. 2017;152(9):827-34.

39. Wang YY, et al. Effect of the tailored, family-involved Hospital Elder Life Program on postoperative delirium and function in older adults: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2020;180(1):17-25.

41. Weimann A, et al. ESPEN practical guideline: clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2021;40(7):4745-61.

43. Igwe EO, et al. Incidence of postoperative delirium in older adults undergoing surgical procedures: a systematic literature review and meta-analysis. Worldviews Evid Based Nurs. 2023;20(3):220-37.

46. Conselho Federal de Medicina (Brasil). Resolução CFM nº 1.995, de 9 de agosto de 2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Diário Oficial da União. 31 ago 2012. Lida em transcrição (normaslegais.com.br); conferir no portal do CFM.

Vancouver abreviado (1º autor, et al.); lista completa com DOI/PMID no dossiê da aula.

Fontes das figuras (7)

F1 — Kim AJ, Reardon-Lochbaum R, Kalliath M. Sigmoid volvulus following mechanical bowel preparation in an elderly patient. Cureus. 2026;18(4):e106570. Fig. 2. CC BY 4.0. PMC13150942. doi:10.7759/cureus.106570

F2 — Kim AJ, Reardon-Lochbaum R, Kalliath M. Sigmoid volvulus following mechanical bowel preparation in an elderly patient. Cureus. 2026;18(4):e106570. Fig. 3. CC BY 4.0. PMC13150942. doi:10.7759/cureus.106570

F3 — Snitkjær C, Rehné Jensen L, í Soylu L, et al. Impact of clinical frailty on surgical and non-surgical complications after major emergency abdominal surgery. BJS Open. 2024;8(3):zrae039. Fig. 3. CC BY 4.0. PMC11126315. doi:10.1093/bjsopen/zrae039

F4 — Tan HL, Chia STX, Nadkarni NV, et al. Frailty and functional decline after emergency abdominal surgery in the elderly: a prospective cohort study. World J Emerg Surg. 2019;14:62. Fig. 1. CC BY 4.0. PMC6937965. doi:10.1186/s13017-019-0280-z

F5 — Girnyi S, Boccardi V, Montanari E, et al. Does chronological age adequately stratify perioperative risk? A prospective multicenter cohort study using frailty and handgrip strength. J Clin Med. 2026;15(11):4187. Fig. 1. CC BY 4.0. PMC13258233. doi:10.3390/jcm15114187

F6 — Ronza FM, Di Gennaro TL, Buzzo G, et al. Diagnostic role of multi-detector computed tomography in acute mesenteric ischemia. Diagnostics (Basel). 2024;14(12):1214. Fig. 4. CC BY 4.0. PMC11202795. doi:10.3390/diagnostics14121214

F7 — Haug K, Buffington A, Zelenski A, et al. Best Case/Worst Case: protocol for a multisite randomised clinical trial of a scenario planning intervention for patients with kidney failure. BMJ Open. 2022;12(11):e067258. Fig. 1. CC BY-NC 4.0. PMC9639110. doi:10.1136/bmjopen-2022-067258